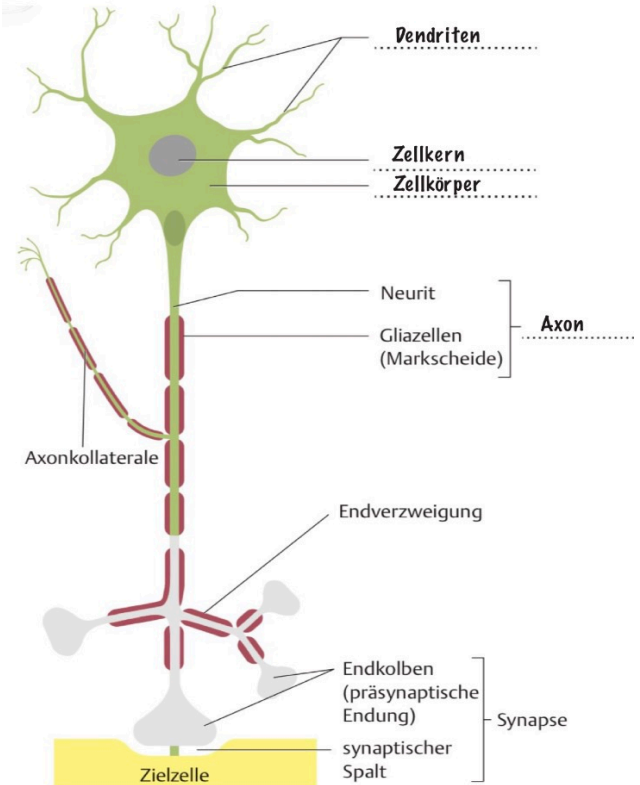
Klausur

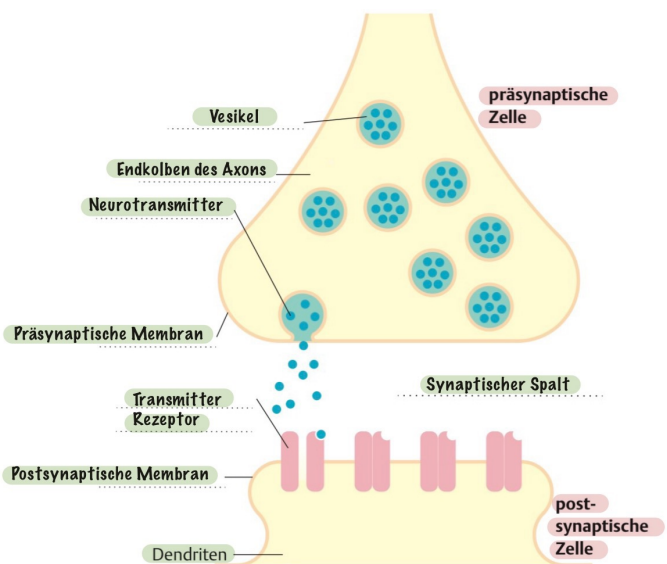
Depression & Burnout

Anatomie

Das Neuron



Die Synapse



Psychatrie

Beobachtungsschwerpunkte im Psychatrischen Bereich

- Gesprächsbereitschaft
- Schwingungsfähigkeit
- Mimik, Gestik, Sprache, Körperhaltung
- Körperpflege und Kleidung
- Krankheitseinsicht und Wirkung und Nebenwirkung der Medikamente
- Bewältigung der Alltagsaufgaben
- Integration auf Station
- Verhalten bei Besuch/ Freizeitverhalten

Beziehungsgestaltung - Bezugspflege

Bezugspflegeaufgaben:

- Pflegeanamnese, Pflegeplanung, Evaluation
- regelmäßige Bezugspflegegespräche
- Reflexion von Verhalten
- Förderung der Therapiemotivation
- Durchführung von begleitenden therapiebezogenen Interventionen
- Beratung von Angehörigen

Ziel:

- Pat. kann Möglichkeiten der psychiatrischen Behandlung nutzen
- Pat. fühlt sich sicher und angenommen
- Pat. hat wenig /keine Angst vor der Behandlung
- Pat. arbeitet aktiv mit

Depression

Definition

Eine Depression ist eine Affektive Störung mit krankhaft niedergedrückter Stimmung, welche mit psychischen, psychosozialen und körperlichen Symptomen einhergehen kann.



Symptome

Gedanken:

- Grübeln, Selbstvorwürfe, kein Selbstvertrauen, Konzentrationsschwierigkeiten, Entscheidungsschwierigkeiten, negative und pessimistische Betrachtung der Zukunft, Suizidgedanken, Todeswunsch

Körper:

- innere Nervosität, Appetitverlust oder gesteigerter Appetit, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Engegefühl in der Brust, Verdauungsbeschwerden, Beeinträchtigung der Atemwege

Emotionen:

- Angst, Leere, Sinnlosigkeit, Ausweglosigkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Einsamkeit, Gefühle der Wertlosigkeit und Angst, Gereiztheit, Empfindlichkeit

Verhalten:

- Antriebslosigkeit (häufig am Morgen) oder unproduktive Getriebenheit und Hektik, Lustlosigkeit, sozialer Rückzug, schnelles zu weinen, keine Energie, Jammern und Klagen

Risikofaktoren

Psychosoziale Faktoren:

- Belastende/einschneidende Lebensereignisse (Verlusterfahrungen, Traumatisierungen,
- Geburt eines Kindes, Migration, ...)
- Kritische mit Stress verbundene Lebensereignisse
- Frühere Depression

Körperliche Erkrankungen:

- Hirntumor
- Entzündliche Darmerkrankungen/chronische Erkrankungen Usw.

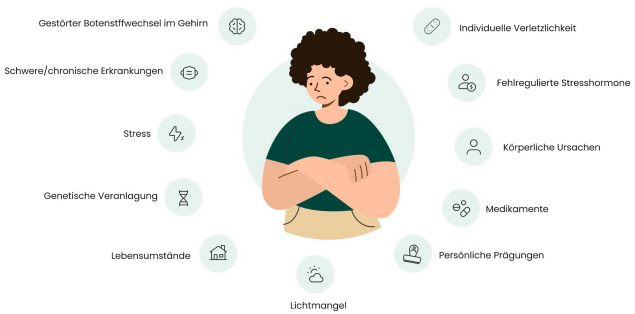
Medikamente:

- Antihypertensiva (Betablocker)
- Parkinsonmedikamente (L-Dopa)

Warum sind Frauen häufiger betroffen?

- Hormonelle Unterschiede zu Männern
- Mögliche soziale Unterschiede (Status, Einkommen, Abhängigkeiten gegenüber anderen, ...)
- Unterschiede in der Diagnosestellung zu Männern! (schnellere Diagnostik)
- Soziale Rollen/Rollenkonflikte deutlich spürbar

Risikofaktoren



Diagnostik

- Mithilfe von systematischen Fragebögen
- Internistische und neurologische Abklärung für Ausschlussverfahren (Zd. n. Herzinfarkt, Hormonstörungen, Krebserkrankungen)

Formen

- Unipolare Depression
- Bipolare Störung
- Wochenbettdepression
- Saisonale Depression
- Larvierte Depression

Therapie

- Medikamentöse Therapie
- Psychotherapie
- Nicht medikamentöse Verfahren

Burnout

Definition

Burnout ist ein chronischer erschöpfungszustand (körperlich und geistig). Menschen mit einem burnout haben ein einhergehendes krankheitsgefühl länger als 6 Monate. Die Folge ist meist eine lang anhaltende Stressbelastung. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, die biochemischen Stressreaktionen zu verarbeiten

Risikofaktoren

Äußere Faktoren	Innere Faktoren
• Berufliche Überbelastung • Nicht ausreichende Wertschätzung • Benachteiligung, fehlende Fairness • Wenig Einfluss auf tägliche Aufgaben • Mobbing, Konflikte • Fehlende Unterstützung • Hoher Termin- oder Zeitdruck	• Selbstzweifel • Perfektionismus • Selbstüberforderung • Die Eigenschaft nicht Nein sagen zu können • Unerreichbare Ziele • Neigung zu starker Selbstkritik • Starkes Bedürfniss nach Anerkennung

Symptome

Seelische Symptome	Körperliche Symptome
• Frustration • Versagensängste • Überforderung • Ängstlichkeit • Depressive Verstimmtheit	• chronische Müdigkeit • Verspannungen • Kopfschmerzen • Herzrhythmusstörungen • Schlafstörungen • Libidoverlust • Neigung zu starken Alkohol- oder Kaffeekonsum

3 Stadien nach Freudenberg



1. Alarmphase
2. Widerstandsphase
3. Erschöpfungsphase

Burnout vorbeugen

- Körperliche Bewegung
- Autogenes Training
- Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
- Achtsamkeitsübungen
- Meditation
- Atemübungen (auch Stimulation des Vagusnervs)
- Stärkung des sozialen Netzes
- Zeitspannen ohne Medienkonsum, Lärm und Aufgaben (Reizreduktion!)
- Individuelle Energieräuber (auch Personen!) vermeiden
- Und alles was individuell gut tut

Depression VS Burnout

Burnout ist meist sehr situationsbezogen (z.B. Arbeit) und greift erst in späteren Phasen auf andere Lebensbereiche über
Eine Depression hingegen wirkt sich bereits zu Beginn in allen Lebensbereichen aus

Im Gegensatz zur Depression durchlaufen Betroffene bei einem Burnout meist einen Prozess (ständige Belastung → Überlastung)

Beim Burnout wird im Laufe der Depersonalisierung und der Herstellung von Distanz vieles abgewertet, oft auch in Form von Zynismus. Das tritt bei Depressionen nicht auf

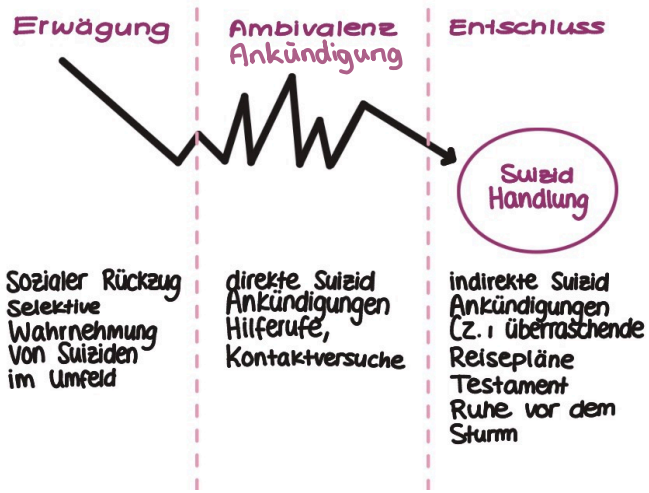
in der vollen Ausprägung jedoch besteht praktisch kein Unterschied mehr zwischen einem Burnout und einer Depression. Man spricht hier auch von einer Erschöpfungsdepression

Suizid

Definition

Suizid, auch Selbsttötung genannt bedeutet, das das Ziel einer absichtlichen Beendigung des Lebens besteht. Alle Gedanken und Handlungen, die das Ziel haben, sich selbst zu töten.

Stadien der suizidalen Entwicklung



Alarmzeichen

- Suiziddrohungen oder Ankündigung (Parasuizid)
- Große Hoffnungslosigkeit mit Äußerungen wie „Ich sehe kein Sinn mehr in meinem Leben"
- Angelegenheiten ordnen, Abschied nehmen (Wertsachen verschenken, Testament, Abschied von Freunden oder Familie

Pflegerische Maßnahmen

- Suizidabsichten erkennen
- Selbsttötungsabsichten offen und einfühlsam ansprechen
- immer wieder Gespräche anbieten
- regelmäßige und engmaschige Sichtkontrollen durch PP
- Absprachen treffen, Antisuizidpaket vereinbaren auch verbal mit PP möglich
- Sicherheit schaffen durch Zimmerkontrollen
- Kollegen und Arzt informieren auch schriftlich!

Begriffserklärungen

Suizidversuch: absichtliche Selbstschädigung zum Zweck der Selbsttötung, die jedoch nicht zum Tod führt

Parasuizid: Suizidversuch, der die Umwelt auf die besondere (verzweifelte) Situation des Betroffenen aufmerksam machen soll (appellativer Suizid → Aufruf zur Hilfeleistung)

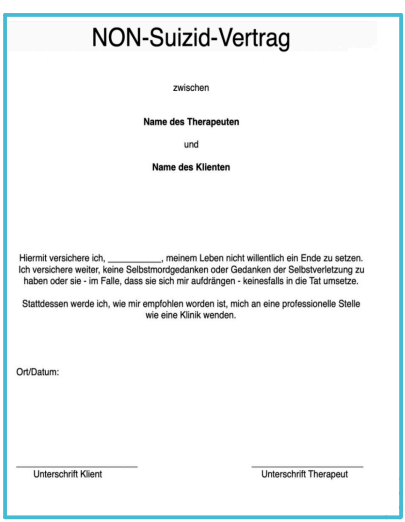
Bilanzsuizid: Suizid nach rationalem Abwägen des Für und Wider des Suizids (#Sterbehilfe)

erweiterter Suizid: Suizid unter Mittötung einer weiteren Person ohne deren Mitentscheidung (bspw. Infantizid)

gemeinsamer Suizid: gemeinsam geplanter und durchgeführter Suizid

Antisuizidpaket

Auch: Suizidpakt; Non-Suizid-Vertrag, u.a. Gemeinsam getroffene Vereinbarung zwischen PatientIn und Therapeut. Bis zum nächsten vereinbarten Zeitpunkt wird kein Suizidversuch unternommen. In der Not wird sich sofort an den Therapeuten gewendet bzw. andere vereinbarte Strategien zur Selbstrettung



NON-Suizid-Vertrag

zwischen

Name des Therapeuten

und

Name des Klienten

Hiermit versichere ich, _____, meinem Leben nicht willentlich ein Ende zu setzen. Ich versichere weiter, keine Selbstmordgedanken oder Gedanken der Selbstverletzung zu haben oder sie - im Falle, dass sie sich mir aufdrängen - keinesfalls in die Tat umsetze.

Stattdessen werde ich, wie mir empfohlen worden ist, mich an eine professionelle Stelle wie eine Klinik wenden.

Ort/Datum:

_____ Unterschrift Klient

_____ Unterschrift Therapeut

Rechtliche Aspekte

Freiheitsbeschränkende Maßnahme - Definition

- Eine Freiheitsbeschränkung liegt vor, wenn jemand gegen seinen Willen daran gehindert wird, einen bestimmten für ihn an sich zugänglichen Ort aufzusuchen oder sich dort aufzuhalten.
- Eine Freiheitsentziehung ist die schwerste Form der Freiheitsbeschränkung. Sie liegt vor, wenn die – tatsächlich und rechtlich an sich gegebene – körperliche Bewegungsfreiheit nach jeder Richtung hin aufgehoben wird.

- Strengste Form der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen sind die freiheitsentziehenden und genehmigungspflichtigen Maßnahmen im Sinne §1906 Abs. 4 BGB
- Liegen vor wenn Pflegebedürftigen über längeren Zeitraum und regelmäßig die Freiheit entzogen wird

Unterbringung/ Zwangseinweisung

Unterbringung oder Zwangseinweisung gegen den Willen der betroffenen Person stellt Eingriff in die Grundrechte des Menschen dar

Rechtliche Grundlagen, die diese Maßnahmen ermöglichen:

- Zivilrechtlich nach BGB – Betreuungsrecht
- Landesrechtlich nach PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psych. Krankheiten 2016)
- Strafrechtlich nach StGB

Vorraussetzung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen

sind nur zum Wohl des Bewohners/Patienten zulässig bei:

- krankheits- oder behinderungsbedingte Gefahr einer Selbsttötung
- Um eine erhebliche Gesundheitsschädigung abzuwenden oder
- wenn eine Untersuchung, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, deren Sinn und Zweck der Betroffene infolge Krankheit oder Behinderung nicht einzusehen vermag
- In Ausnahmefällen, bei der öffentlich-rechtlichen Unterbringung (Zwangseinweisung), kann auch der Schutz Dritter im Vordergrund stehen

Medikamentöse Behandlung

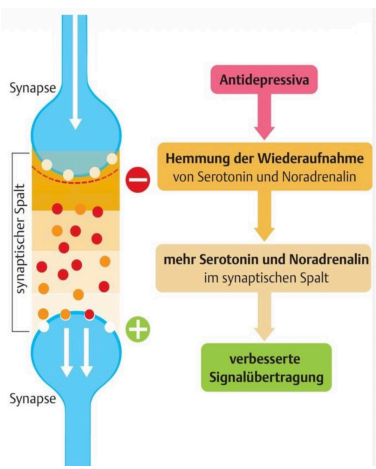
Therapie mit Antidepressiva

- Regelmäßige Einnahme besonders wichtig
- Medikamentöse Therapie wirkt in Phase tiefer Depression manchmal sinnlos → Pflegende müssen gut begleiten und beraten
- Meist dauert es eine Zeit bis Med. stimmungsaufhellend wirken (1-4 Wochen); antriebsteigernd nach einem Tag!
- Antidepressiva erhöhen die Konzentration der Neurotransmitter im synaptischen Spalt → bessere Signalübertragung von Nervenzelle zu Nervenzelle

ACHTUNG
Da Menschen mit Depressionen häufig Suizidgedanken haben, ist es notwendig, darauf zu achten, dass die
Medikamente nicht für einen möglichen Suizidversuch gesammelt werden.

Wirkmechanismus

- Verbessern Stimmungslage und Antrieb
- Eingesetzt bei Depressionen, bipolaren Störungen,
- Angst- und Zwangsstörungen
- Konzentration der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin erhöht sich im synaptischen Spalt zwischen 2 Nervenzellen
- Verbesserte Übertragung der Signale zwischen Nervenzellen
- Antidepressiva verhindern die Wiederaufnahme dieser Botenstoffe in Nervenzellen
- Botenstoffe bleiben also im synaptischen Spalt



3 Formen

- SSRI, SSNRI und SNRI
- MAO-Hemmer
- Tri- und tetrazyklische Antidepressiva

Nicht Medikamentöse Behandlung

Schlaf Entzugs Therapie

Lichttherapie

Elektrokrampftherapie

Beziehungsarbeit ist extrem wichtig

Milieugestaltung

Bewegungstherapie

Musiktherapie

Training der Alltagsbewältigung

Beschäftigungs- und Arbeitstherapie (Ergotherapeuten u.ä.)

Patientenedukation

Sozialarbeit